

Divertículo uretral

WARWIKI

Información para el paciente · Una pequeña bolsa que sale de la uretra y acumula orina

Un divertículo uretral es una pequeña **bolsa o saco** que se forma a partir de la uretra — el conducto que lleva la orina hacia afuera — casi siempre en las mujeres. Un poco de orina puede acumularse en la bolsa, lo que causa goteo, molestias, infecciones o dolor con las relaciones sexuales. A menudo pasa desapercibido durante años, pero una vez que se reconoce tiene muy buen tratamiento.

Acerca de esta afección

Las señales clásicas son las **"tres D"**:

- **Goteo (dribbling)** — se escapa un poco de orina justo después de terminar de orinar
- **Disuria** — ardor o molestia al orinar
- **Dispareunia** — dolor con las relaciones sexuales

Otras señales incluyen **infecciones urinarias repetidas**, urgencia o frecuencia, o un bulto sensible que se siente en la pared frontal de la vagina y que puede liberar líquido al presionarlo.

Qué la causa

Se cree que empieza cuando pequeñas glándulas alrededor de la uretra se **bloquean e infectan**, luego se rompen hacia la uretra y dejan una bolsa que se llena de orina. No es cáncer y no es causada por nada que usted haya hecho.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Uretra

El conducto que lleva la orina hacia afuera del cuerpo.

Divertículo

Una bolsa o saco que se abulta a partir de un conducto hueco.

Las "3 D"

Goteo, disuria (ardor) y dispareunia (dolor con las relaciones sexuales).

Resonancia magnética (MRI)

El mejor estudio para mapear la bolsa antes de la cirugía.

Diverticulectomía

Cirugía para extirpar la bolsa y reparar la uretra.

Colgajo de Martius

Un pequeño colgajo de tejido que a veces se usa para reforzar la reparación.

Cistoscopia

Una mirada al interior de la uretra y la vejiga con una cámara delgada.

¿NECESITO CIRUGÍA? No siempre. Una bolsa pequeña que no causa síntomas simplemente se puede vigilar. Pero cuando causa goteo, infecciones, dolor o un bulto molesto, extirparla (una diverticulectomía) es la solución definitiva. Su cirujano primero la mapeará con cuidado con una resonancia magnética (MRI).

Cómo se diagnostica

- Un examen — un bulto sensible en la pared frontal de la vagina que puede liberar líquido al presionarlo
- Una **resonancia magnética (MRI)**, que es la mejor manera de mostrar el tamaño y la forma de la bolsa
- A veces una **cistoscopia** para ver la abertura desde adentro

Cómo se trata

- 1 **Vigilancia** para una bolsa pequeña y sin síntomas.
- 2 **Tratar las infecciones** primero, si las hay.
- 3 **Diverticulectomía** — cirugía a través de la vagina para extirpar la bolsa y reparar con cuidado la uretra por capas, a veces con un pequeño colgajo de tejido.
- 4 Se deja una **sonda** mientras cicatriza, y por lo general se hace una **radiografía de cicatrización** antes de retirarla.

Bueno saber

- La reparación es delicada — espere llevar una sonda durante un par de semanas después.
- La mayoría de las personas obtiene un excelente alivio; en ocasiones una bolsa puede volver a aparecer o surgir un nuevo escape, lo cual se puede tratar.
- La cirugía por lo general se planifica cuando cualquier infección se ha calmado.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre, escalofríos o dolor pélvico que empeora
- **No puede orinar**, o la sonda deja de drenar (después de la cirugía)
- Sangrado abundante, o un nuevo escape continuo

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un divertículo uretral es una pequeña bolsa que sale de la uretra — piense en las "3 D" (goteo, ardor, dolor con las relaciones sexuales) y las infecciones repetidas.
2. La resonancia magnética (MRI) es la que mejor lo mapea. Las bolsas pequeñas y sin síntomas se pueden vigilar; las molestas se extirpan con una reparación cuidadosa.
3. Espere una sonda y una radiografía de cicatrización después de la cirugía. Llame si tiene fiebre, no puede orinar o un nuevo escape continuo.